

Guide d'administration

Protocole *docétaxel-darolutamide*

Rédaction : *mai 2023*

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹

Traitement de première intention du cancer de la prostate métastatique sensible à la castration.

En association avec une thérapie de privation androgénique (p.ex. : agoniste LHRH, antagoniste LHRH ou orchidectomie bilatérale).

ECOG 0-1.

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (2023-05) : En cours d'évaluation
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (2023-05) : non-inscrit

2. Guide d'administration¹

2.1. Description du protocole

Le docétaxel est administré aux 3 semaines pour 6 cycles. L'administration du premier cycle doit se faire dans les 6 semaines suivant le début de la prise de darolutamide.

Le darolutamide est administré deux fois par jour en continu jusqu'à progression de la maladie ou toxicité importante.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Médicament	Dose	Description
Docétaxel	75 mg/m ² Jour 1	› IV soluté; dans 250 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 1 heure (concentration finale visée : 0,3 – 0,74 mg/ml). › Les sacs et les tubulures utilisés pour l'administration ne doivent pas contenir de chlorure de polyvinyle (PVC) afin d'éviter toute exposition au DEHP. Une tubulure sans filtre est recommandée.
Darolutamide	600 mg 2 fois par jour En continu	› Par voie orale à un intervalle d'environ 12 heures matin et soir. › Avec nourriture. › Doit être avalé entier (ne pas mâcher, écraser, dissoudre ni couper). › Comprimés de 300 mg.
› Répéter aux 21 jours pour 6 cycles (docétaxel). Le darolutamide est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable. › L'administration du premier cycle doit se faire dans les 6 semaines suivant le début de la prise de darolutamide. › Si le docétaxel est interrompu ou cessé en cours de traitement, le darolutamide doit être poursuivi^{2,5}.		
› Prémédication obligatoire (docétaxel): Dexaméthasone 8 mg PO BID pour 3 doses à débiter le jour précédant le docétaxel. Dans l'étude pivot ainsi que dans la monographie, on précise : 12 heures, 3 heures et 1 heure pré-docétaxel^{2,3}. La posologie BID pour 3 doses permet de prévenir les réactions d'hypersensibilité et est plus simple à prendre pour le patient. ○ Alternative⁶ : Si les 3 doses de dexaméthasone pré-docétaxel n'ont pas été prises par le patient et que le traitement ne peut pas être retardé, il est recommandé d'administrer la dexaméthasone 10 mg IV et la diphenhydramine 50 mg IV pré-docétaxel et de poursuivre la dexaméthasone 8 mg po BID pour 3 doses. Cependant, la substitution des 3 doses de dexaméthasone PO pré-docétaxel par la dexaméthasone IV et la diphenhydramine IV ne procure pas le même bénéfice au niveau de la diminution du risque et de la sévérité de la rétention liquidienne, ainsi que de la sévérité de la réaction d'hypersensibilité.		
Considérations spéciales : › Dans l'étude pivot, le docétaxel pouvait être administré en combinaison avec de la prednisone à la discrétion de l'investigateur¹. › La solution injectable de docétaxel contient de l'éthanol³ (voir section 4.1 - Effets indésirables). › En cas d'oubli, la dose de darolutamide peut être prise dès que le patient s'en rend compte, mais il ne doit pas doubler la dose suivante. › Les comprimés de darolutamide contiennent du lactose⁴.		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation**
 - Aucune au préalable.
- › **Antémétiques :**
Docétaxel (jour 1) : potentiel émétique faible (10 à 30%)^{7,8}
 - Pré-chimiothérapie : aucun antiémétique à ajouter étant donné la prémédication de dexaméthasone administrée en prévention des réactions d'hypersensibilité et de la rétention liquidienne.

- Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
-
- Darolutamide en continu** : potentiel émétique très faible (< 10 %)⁴
 - Aucun antiémétique recommandé d'emblée
- › **Réactions liées à la perfusion du docétaxel**³,⁹ :
 - Surveillance des signes vitaux toutes les 10 à 15 minutes pendant la perfusion puis selon l'évolution clinique, en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements malgré qu'une réaction puisse avoir lieu lors des cycles subséquents³,⁹.
 - Les patients doivent recevoir la pré-médication obligatoire ([voir section 2.2 – Schéma d'administration](#)).
 - Médication pour choc anaphylactique au chevet : épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine afin de traiter un bronchospasme ou une hypotension.
 - En présence d'une **réaction légère** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un antihistaminique au besoin (anti-H1 +/- anti-H2). Lorsque les signes vitaux sont stables, reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent. Pour les cycles subséquents, envisager l'ajout d'un antihistaminique (anti-H1 et anti-H2) en prémédication, en plus de la dexaméthasone.
 - En présence d'une **réaction sévère** ou d'une anaphylaxie ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique: épinéphrine, oxygène, bronchodilatateurs, antihistaminiques (anti-H1 et anti-H2), corticostéroïdes. Ne pas reprendre le traitement sans consulter un spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Considérer une désensibilisation si aucune alternative de traitement disponible.
- › **Rétention liquidienne avec le docétaxel**³ :
 - La dexaméthasone 8 mg PO BID pour 3 doses à débiter la veille du docétaxel est prescrite pour réduire l'incidence de rétention liquidienne.
- › **Altérations unguéales (ongles) avec le docétaxel**¹⁰ :
 - Tremper les doigts dans la glace pendant la perfusion de docétaxel peut permettre de réduire les altérations unguéales. Le trempage des doigts peut être débuté 15 minutes avant le début de la perfusion et poursuivi jusqu'à 15 minutes après la fin de celle-ci.
- › **Surveillance des myalgies/arthralgies avec le docétaxel**¹¹-¹⁵ :
 - L'acétaminophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opiacé peuvent aider à soulager les symptômes.
 - La gabapentine et la prégabaline pourrait également être tentées.
- › **Surveillance des mucosites avec le docétaxel**³ :
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire). Utilisation des gargarismes au besoin
- › **Surveillance des diarrhées avec le docétaxel**³ :
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale²⁻⁵

Médicament	Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
Docétaxel	Peu importe	Aucun ajustement requis
Darolutamide	Clcr ≥ 30 ml/min/1,73 m ²	100% de la dose
	Clcr 15 à 29 ml/min/1,73 m ²	300 mg PO BID
	Clcr < 15 ml/min/1,73 m ² (incluant patients sous dialyse)	Non étudié

Clcr : clairance à la créatinine

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

3.2.1. Ajustement des doses selon la fonction hépatique pour le docétaxel^{2,3,5}

Médicament	Bilirubine		AST/ALT		PAL*	Ajustement posologique recommandé**
Docétaxel	$\leq$ LSN	et	$\leq 1,5 \times$ LSN	et	$\leq 2,5 \times$ LSN	100% de la dose
	$\leq$ LSN	et	$> 1,5 \times$ LSN	et	$> 2,5 \times$ LSN	Ne pas administrer
	$>$ LSN	et	peu importe	et	peu importe	Ne pas administrer

*Sauf si métastases osseuses et pas d'évidence de dysfonctionnement hépatique¹⁶.

**Certains références suggèrent un ajustement moins sévère que celui proposé par la monographie du produit¹⁷. Le jugement clinique est indiqué si :

- AST/ALT 1,6 – 6 x LSN : administrer 75% de la dose
- AST/ALT $> 6 \times$ LSN : administrer selon jugement clinique

AST : aspartate aminotransférase; ALT : alanine aminotransférase; PAL : phosphatase alcaline; LSN : limite supérieure de la normale

3.2.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique pour le darolutamide^{4,5}

Médicament	Fonction hépatique	Ajustement posologique recommandé
Darolutamide	Insuffisance hépatique légère (Child-Pugh classe A*)	100% de la dose
	Insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh classe B*)	300 mg PO BID
	Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh classe C*)	Non étudié

*Voir [Annexe](#) pour Score Child-Pugh.

3.3. Niveaux de doses^{3,4}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1
Docétaxel	75 mg/m ²	60 mg/m ²
Darolutamide	600 mg PO BID	300 mg PO BID

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

3.4.1. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique pour le docétaxel^{2,3}

Pour les ajustements de dose selon la toxicité hématologique pour le darolutamide, [voir section 3.5.3 – Ajustement des doses selon la toxicité hématologique et non hématologique pour la darolutamide.](#)

Médicament	Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)		Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Docétaxel	≥ 1,5	et	≥ 100	100% de la dose
	≥ 1,0 - < 1,5	et/ou	≥ 50 - < 100	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x10 ⁹ /L. Conserver la même dose au cycle suivant.
	≥ 0,5 - < 1,0*	et/ou	< 50*	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x10 ⁹ /L. Réduire la dose d'un niveau.
	Ou < 0,5 pour > 7 jours Ou Neutropénie fébrile			Considérer l'ajout de filgrastim si neutropénie.

*Consensus d'experts; le protocole de l'étude prévoyait une diminution de dose seulement en cas de neutropénie fébrile ou de neutrophiles < 0,5 x 10⁹/L pour > 7 jours.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique

3.5.1. Ajustement des doses selon la neuropathie pour le docétaxel^{*3}

Médicament	Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
	1	Asymptomatique, perte des réflexes tendineux ou paresthésies (y compris picotements), n'interférant pas avec les fonctions.	Administer 100% de la dose.
	2	Altérations sensorielles ou paresthésies, interférant avec les habiletés (p. ex. : boutonner), mais	Diminuer la dose d'un niveau. Ne pas interrompre le traitement ou considérer retarder le traitement selon

		pas avec les AVQ**.	le contexte clinique.
Docétaxel	3	Altérations sensorielles ou paresthésies interférant avec les AVQ.	Interrompre le traitement jusqu'à résolution (grade ≤ 2). Reprendre à une dose réduite d'un niveau. Si le traitement est interrompu pour plus de 2 semaines, considérer cesser le traitement.
	4	Neuropathie débilante.	Considérer cesser le traitement selon le contexte clinique. Sinon, se référer au grade 3.

*Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

**AVQ : activités de la vie quotidienne

CTCAE version 4.03

3.5.2. Ajustement des doses selon les autres toxicités non hématologiques de grade 3 ou 4 pour le docétaxel³

Médicament	Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Docétaxel	Non hématologique de grade 3-4 (diarrhée, réaction cutanée, etc.)	Interrompre le traitement jusqu'à résolution (grade ≤ 2). Reprendre en diminuant la dose d'un niveau. Si le traitement est interrompu pour > 2 semaines, considérer cesser le traitement.

*Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

CTCAE version 4.03

3.5.3. Ajustement des doses de darolutamide selon la toxicité hématologique et non hématologique²

Grade	Ajustement posologique recommandé
1-2	Aucun ajustement requis
3-4	<u>Si dose à 600 mg PO BID :</u> Suspendre le traitement jusqu'à retour à grade ≤ 2. Reprendre traitement en diminuant la dose d'un niveau. › <u>1^{er} épisode :</u> - Si toxicité résolue ou retour à niveau de base, dose pourrait éventuellement être ré-augmentée à 600 mg PO BID selon jugement clinique. › <u>2^e épisode et dose avait été ré-augmentée à 600 mg PO BID :</u> - Diminuer la dose d'un niveau. Ne pas ré-augmenter la dose. <u>Si dose à 300 mg PO BID :</u> Cesser le traitement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Avec le docétaxel, la **neutropénie** est fréquente et peut être dose-limitante. Dans certains cas, l'utilisation de filgrastim pourrait être envisagée. Avec le darolutamide, la neutropénie est rapportée mais est habituellement peu sévère⁴. Dans l'étude pivot, la neutropénie fébrile a été rapportée chez 6% des patients¹. La **thrombocytopénie** est beaucoup moins fréquente mais peut également demander une diminution de dose ([voir section 3.5.1 – Ajustement des doses selon la toxicité hématologique pour le docétaxel](#))^{1,3}. L'**anémie** est fréquente¹.

Les **nausées et vomissements** reliés au docétaxel sont généralement d'intensité faible et bien contrôlées avec la prémédication de dexaméthasone en prévention des réactions d'hypersensibilité et de la rétention liquidienne ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))^{3,4,7,8}.

La **diarrhée** est fréquente avec le docétaxel, mais habituellement d'intensité légère³. La constipation est aussi possible et elle est plus fréquente au cours des 6 premiers mois de traitement³.

Les **mucosites** sont aussi fréquentes avec le docétaxel mais plus souvent de grades 1 et 2³.

Les **réactions d'hypersensibilité** avec le docétaxel sont rapportées globalement chez 21% des patients, graves dans 4 % des cas. Elles sont plus susceptibles de se produire lors des deux premiers cycles et se manifestent généralement au cours des premières minutes de la perfusion³. La prémédication avec la dexaméthasone ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) permet de réduire la sévérité de cette réaction³.

Description des réactions :

- **Réactions légères** : bouffées congestives, réactions cutanées localisées avec ou sans prurit, oppression thoracique, dyspnée, lombalgie, fièvre, frissons. Cesser la perfusion; les symptômes disparaissent souvent après l'arrêt de la perfusion, au besoin administrer un antihistaminique^{3,9}. Si les signes vitaux sont stables, continuer le traitement en administrant une prémédication à base d'antihistaminiques, de corticostéroïdes et de bloqueurs H2. Ne pas continuer le traitement si les symptômes se reproduisent. Considérer une désensibilisation à chaque traitement si aucune alternative de traitement disponible ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))⁹.
- **Réactions sévères** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, nausée, vomissement, sentiment d'anxiété, anaphylaxie. Arrêter de la perfusion et débiter les traitements de support^{3,9}. Ne pas continuer le traitement sans consulter un spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Si aucune alternative de traitement n'est disponible, considérer une désensibilisation à chaque perfusion ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))⁹.

La **rétention liquidienne** est fréquente et dépendante de la dose cumulative avec le docétaxel. Une rétention modérée à sévère peut se manifester à une dose cumulative moyenne de plus de 800 mg/m². À noter que la dose cumulative maximale de docétaxel avec 6 cycles est de 450 mg/m². La rétention liquidienne peut se présenter sous forme d'œdème périphérique ou plus rarement, d'épanchement pleural, d'ascite, d'épanchement péricardique et de gain de poids. La prémédication avec la dexaméthasone ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) permet de réduire l'incidence et la sévérité de cette réaction de même que d'en retarder l'apparition³.

La **neurotoxicité** (paresthésie/dysesthésie) est fréquente avec le docétaxel et peut nécessiter l'arrêt du traitement. En présence de neuropathies périphériques sévères, il est recommandé de réduire la dose ([voir section 3.5.1 - Ajustement des doses selon la neuropathie pour le docétaxel](#))³. Une toxicité neuromotrice principalement caractérisée par de la faiblesse est plus rare mais possible.

Les **myalgies/arthralgies** reliées au docétaxel sont souvent présentes et peuvent être très inconfortables ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). L'acétaminophène, un AINS ou un opiacé peuvent être utilisés pour traiter les symptômes^{11,12}. La gabapentine et la prégabaline pourraient également être tentées¹³⁻¹⁵.

Les **réactions cutanées** avec le docétaxel se manifestent habituellement sous forme de rash, avec ou sans prurit, touchant surtout les pieds et les mains, parfois les bras, le visage ou le thorax. Des réactions cutanées sévères incluant le lupus érythémateux, la dermatite bulleuse, l'érythème polymorphe, le syndrome de Stevens-Johnson, la nécrolyse épidermique toxique et des modifications cutanées de type sclérodermie ont été rapportées. Le traitement peut être continué en présence de réactions mineures (érythème localisé) mais dans les cas sévères une diminution de dose ou l'arrêt du traitement peuvent être nécessaires³. Une **réaction cutanée** est aussi possible avec le darolutamide, mais l'incidence est faible⁴.

Des cas de **cardiopathie ischémique**, parfois mortels, ont été rapportés avec le darolutamide⁴. Il est recommandé d'optimiser la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires (hypertension, diabète, dyslipidémie) et de surveiller étroitement les signes et symptômes de cardiopathie ischémique chez les patients sous darolutamide. À noter que le traitement antiandrogénique peut augmenter le risque cardiovasculaire⁵.

Le darolutamide peut entraîner de l'**hypertension artérielle**. Un suivi régulier de la tension artérielle est nécessaire. En cas d'hypertension artérielle, un traitement anti-hypertenseur doit être débuté ou la dose augmentée si un tel traitement est déjà en place. Le darolutamide n'a pas été étudié chez les patients atteints d'hypertension grave non contrôlée (pression systolique au repos ≥ 160 mm Hg et/ou pression diastolique au repos ≥ 100 mm Hg)^{2,4}.

Rarement, des **lésions hépatiques d'origine médicamenteuse associées à des taux élevés de transaminases** ont été signalées avec le darolutamide⁴. Ces élévations étaient réversibles après l'arrêt du traitement. Il est recommandé de cesser définitivement le traitement si des élévations des transaminases évoquent des lésions hépatiques idiosyncrasiques d'origine médicamenteuse.

Des **crises d'épilepsie** ont été rapportées avec le darolutamide (< 1%), dont un événement de grade 3⁴. Il est recommandé de considérer l'arrêt du traitement en présence de convulsions survenues durant le traitement⁵. Les patients épileptiques n'étaient pas exclus de l'étude.

La **fatigue** accompagnée d'asthénie reliée au docétaxel, est fréquente et peut être dose-limitante³. Avec le darolutamide, la fatigue est l'effet indésirable le plus fréquent⁴.

L'**alopécie** avec le docétaxel est totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils). Les cheveux devraient repousser après l'arrêt du traitement mais dans certains cas, la perte est demeurée permanente malgré l'arrêt du docétaxel³. L'alopecie n'est pas rapportée avec le darolutamide.

Les **altérations unguéales (ongles)** reliées au docétaxel sont fréquentes et la sévérité est associée à la dose cumulative administrée¹⁰. Elles peuvent se présenter par une dépigmentation ou une

hyperpigmentation et plus rarement, une onycholyse avec douleur ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Elles se résorbent habituellement dans les 6 à 12 mois suivants l'arrêt du traitement¹⁰.

Le docétaxel est **vésicant** (extravasation)¹⁸.

Le docétaxel contient une certaine quantité d'**éthanol** qui est variable selon le fabricant³. Il faut tenir compte des effets possibles de l'éthanol, y compris ceux sur le système nerveux central. La quantité d'éthanol contenu dans une dose de docétaxel de 75 mg/m² est d'environ 2,07 g/m² (au plus, selon le fabricant). Ceci représente 3,8 g d'éthanol pour un patient avec une surface corporelle de 1,85 m², soit un peu plus d'un quart de verre standard. Cette quantité d'éthanol est moindre en proportion que celle retrouvée dans le paclitaxel.

Des cas de **toxicité pulmonaire** ont été rapportés avec le docétaxel. On a rapporté des cas d'insuffisance respiratoire aiguë, de pneumonie interstitielle/pneumonite, de maladie pulmonaire interstitielle, d'infiltration pulmonaire, de fibrose pulmonaire, d'insuffisance respiratoire et de recrudescence d'effets indésirables associés à une radiothérapie antérieure, qui ont été occasionnellement associés à des issues fatales. Des cas de pneumonite radique ont été signalés chez les patients recevant une radiothérapie concomitante^{3,19}. Le risque de toxicité pulmonaire est plus élevé lorsqu'associé à la radiothérapie¹⁰. Une reconnaissance précoce des effets indésirables respiratoires pourrait permettre un traitement hâtif à l'aide de corticostéroïdes^{10,19}.

Tableau des effets indésirables^{1,4}

Effets indésirables* n=652	Tous grades (%)	Grade 3-4 (%)
Alopécie	40,5	-
Neutropénie	51	34
Fatigue	33,1	N.D.
Anémie	96	6
Arthralgie	27,3	N.D.
Œdème périphérique	26,5	N.D.
Diarrhée	25,6	N.D.
Constipation	23	0,3
Diminution de l'appétit	19	0,2
Augmentation du poids	18	2
Augmentation taux ALT	42	4
Douleur aux extrémités	15,0	0,3
Augmentation taux AST	44	4
Hypertension	14	7
Hyperglycémie	75	9

CTCAE version 4.03

N.D. =non disponible

* Le tableau reflète les effets indésirables survenus tout au long de l'étude, et non pas lors de la prise de darolutamide seule.

4.2. Interactions cliniques significatives³⁻⁵

Le **docétaxel** est un substrat majeur du CYP3A4 et un substrat mineur de la glycoprotéine-P (gp-P).

Le **darolutamide** est un substrat mineur du CYP3A4 et de la glycoprotéine-P. Il est aussi un substrat de la protéine de résistance au cancer du sein (BCRP). *In vitro*, il est aussi inhibiteur de la BCRP, de la gp-P et des polypeptides transporteurs d'anions organiques (OATP) 1B1 et 1B3. L'administration de darolutamide ainsi que d'un substrat de la gp-P ne semble pas causer d'interaction médicamenteuse significative⁴. Le darolutamide est un faible inducteur du CYP3A4.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 3A4*	Docétaxel	Augmentation de la concentration plasmatique du docétaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Dans certains cas, une diminution de dose du docétaxel jusqu'à 50% pourrait être envisagée.
Inhibiteurs du CYP450 3A4*	Docétaxel	Augmentation de la concentration plasmatique du docétaxel. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, surveiller les toxicités associées au docétaxel et ajuster la dose.
Médicament à la fois inhibiteur puissant du CYP450 3A4 et inhibiteur de la gp-P et de la BCRP (ex : itraconazole)	Darolutamide	Augmentation de la concentration plasmatique du darolutamide. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration, si possible. Si impossible, surveiller étroitement les toxicités associées au darolutamide.
Inducteurs modérés et puissants du CYP 450 3A4	Docétaxel	Diminution de la concentration plasmatique du docétaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Médicament à la fois inducteur puissant du CYP 450 3A4 et inducteur de	Darolutamide	Diminution de la concentration plasmatique du darolutamide.	Éviter la co-administration.

la gp-P (ex : rifampin)		<i>Sévérité : majeure</i>	
Inhibiteurs de la gp-P	Docétaxel	Augmentation de la concentration plasmatique du docétaxel. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs de la gp-P	Docétaxel	Diminution de la concentration plasmatique du docétaxel. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration.
Substrat de la BCRP ou de l'OATP1B1 ou de l'OATP1B3 (ex : rosuvastatine)	Darolutamide	Augmentation possible de l'exposition du substrat. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration, si possible. Si impossible, surveiller les toxicités associées au substrat. Dose maximale de rosuvastatine si combiné au darolutamide : 5 mg die.
Vaccins vivants	Docétaxel	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire²⁻⁴

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, phosphatase alcaline, tension artérielle
Avant chaque cycle de docétaxel (maximum 72 heures avant)	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, phosphatase alcaline, tension artérielle
Tous les mois ou périodiquement (lorsque darolutamide seul)	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, tension artérielle

5. Références

1. Smith MR, Hussain M, Saad F, Fizazi K, Sternberg CN, Crawford D et coll. Darolutamide and Survival in Metastatic, Hormone-Sensitive Prostate Cancer. *N Engl J Med* 2022;386:1132-42.
2. Protocole de : Smith MR, Hussain M, Saad F, Fizazi K, Sternberg CN, Crawford D et coll. Darolutamide and Survival in Metastatic, Hormone-Sensitive Prostate Cancer. *N Engl J Med* 2022;386:1132-42.
3. Sanofi-Aventis. Monographie du docetaxel (Taxotere), Laval, Canada. Juin 2020.
4. Bayer Inc. Monographie du darolutamide (Nubeqa). Mississauga, Canada. Mai 2023.
5. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 13 avril 2023.
6. Communication professionnelle écrite de Sanofi-Aventis Canada Inc. Février 2016.
7. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arseneault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65p. Disponible à l'adresse : https://www.geoq.info/pub/documents/antiemetiques/antiemetiques_inesss-cepo-pqc_135.pdf
8. Basch E, Prestrud AA, Hesketh PJ, Kris MG, Fever PC, Somerfield MR et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol* 2011; 29(31): 4189-98
9. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
10. Ho MY et Mackey JR. Presentation and management of docetaxel-related adverse effects in patients with breast cancer. *Cancer Management and Research*. 2014; 6:253-259.
11. Nguyen VH, Lawrence HJ. Use of gabapentin en the prevention of taxane-induced arthralgias and myalgias. *J Clin Oncol* 2004 ;22(9) :1767-9.
12. Turker H, Unsal M, Onar MK. Gabapentin in taxane-induced arthralgias. *The pain clinic* 2006 ;18 (3) :271-6.
13. Henke Yarbrow C, Wujcik D, Holmes Gobel B. Cancer Symptom Management. 4th Edition, 2014; <https://books.google.ca/books?id=VraStw2m7kAC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&source=bl&ots=PwJWKhfJss&sig=yDdjYk-WATMxqBiTokFklAw7AQ&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKUewjGnavC7dLKAhVJVhoKHSBNC8w4ChDoAQgiMAE#v=onepage&q=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&f=false>
14. Saibil S, Fitzgerald B, Freedman OC, Amir E, Napolskikh J Salvo N et coll. Incidence of taxane-induced pain and distress in patients receiving chemotherapy for early-stage breast cancer: a retrospective, outcomes-bases survey. *Current Oncology* 2010; 17(4): 42-47.
15. Zangardi ML. A Taxing Consequence: Taxane Acute Pain Syndrome. *Journal of Hematology Oncology Pharmacy* 2017;7(2):80-82.
16. BC Cancer Agency, Docetaxel; http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Genitourinary/GUPDOC_Protocol.pdf
17. Floyd J, Mirza I, Sachs B, Perry MC. Hepatotoxicity of chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33:50-67
18. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques – Mise à jour. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS; 2019. 89p. Disponible à l'adresse : https://www.geoq.info/pro/documents/extravasation/extravasation_inesss-cepo-pqc_160.pdf
19. Gu C. Docetaxel et effets indésirables respiratoires graves. *Bulletin canadien des effets indésirables* 2013;23(1). Site web : InfoVigilance sur les produits de santé - Canada.ca

6. Annexe

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 – 2,30	> 2,30
Albumine (g/L)	> 35	28 – 35	< 28
Bilirubine (µM/L)	< 35	35 – 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points